

JAARVERSLAG 2025

For better health care,
research &
policymaking



HEALTH DATA AGENCY



Funded by
the European Union
NextGenerationEU

SAMENVATTING

In 2025 groeide het Health Data Agency (HDA) uit tot een solide en goed gestructureerde organisatie die zijn rol als centrale speler in het Belgische gezondheidsdata-ecosysteem verder vormgaf. Het agentschap versterkte haar interne werking door het team uit te breiden, processen te professionaliseren en een moderne IT-architectuur uit te rollen. De nationale datacatalogus werd verder opgebouwd en uitgebreid tot 484 gedocumenteerde dataproducten, conform de FAIR-principes en Europese standaarden, en nieuwe tooling maakte het beheer en de kwaliteit van metadata efficiënter en transparanter. Tegelijkertijd verbeterde het HDA de toegang tot gezondheidsdata via een professioneler systeem voor gegevensverzoeken, ondersteund door de introductie van een Case Manager en de migratie naar een centraal platform voor opvolging. Door grondige analyses bij grote gegevenshouders kreeg het agentschap beter zicht op datastromen, knelpunten en vereisten voor een efficiënter verwerkingsproces, wat de basis legde voor betere samenwerking en meer uniformiteit in complexe aanvragen.

De HDAcademy werd verder uitgebouwd tot een toegankelijk leer- en kennisplatform dat datageletterdheid verhoogt bij professionals, beleidsmakers en burgers. Met 46 beschikbare leermaterialen, nieuwe leerformats en duizenden maandelijkse bezoekers groeide de academy uit tot een belangrijke pijler in het kennisbeleid van de HDA. Ook communicatie nam een prominenter plaats in: via gespecialiseerde media, sociale media, workshops en nationale en internationale events vergrootte het agentschap zijn zichtbaarheid en hielp het burgers en professionals beter te begrijpen wat secundair gebruik van gezondheidsdata inhoudt. In samenwerking met partners, zoals ziekenfondsen en federale instellingen, werd het belang van veilige en verantwoorde datadeling breed uitgedragen.

2025 stond eveneens in het teken van intensieve voorbereidingen voor de implementatie van de European Health Data Space (EHDS). De HDA werkte actief mee aan de ontwikkeling van technische en juridische fundamenteën, onder andere via Europese projecten zoals Tehdas2, HeDERA en SHAIPED. Hierdoor werd vooruitgang geboekt op het gebied van governance, beveiligde analyseomgevingen, interoperabiliteit en grensoverschrijdende data-infrastructuren. België bereikte dankzij deze inspanningen een ontwikkelingsindex van 43%, aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde van 9%.

Verder versterkte de HDA zijn management en governance, met gestructureerde besluitvorming, nauwkeurige financiële opvolging en verdere professionalisering van interne en externe communicatie. Door deze brede vooruitgang ontwikkelde het agentschap zich tot een betrouwbare, efficiënte en toekomstgerichte instelling die klaarstaat om in de komende jaren een sleutelrol op te nemen in de datagedreven transformatie van de Belgische gezondheidszorg.



AFKORTINGEN

ADBA	Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie
AI	Artificial Intelligence
BCR	Belgian Cancer Registry
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
DCAT-AP	Data Catalog Application Profile
EHDS	European Health Data Space
EU-RRF	European Union Resilience and Recovery Fund
FAGG	Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
FOD VVVL	FOD Volksgezondheid
GDA	Gezondheids(zorg)data-agentschap
GPT-5	Generative Pretrained Transformer 5
HDA	Health Data Agency
HDAB	Health Data Access Body
HeDERA	EU-project voor data-hergebruik
IMA	Intermutualistisch Agentschap
INAMI — RIZIV	Ziekte- en invaliditeitsverzekering
IVC	Informatieveiligheidscomité
KCE	Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
LMS	Learning Management System
RDF	Resource Description Framework
REST	Representational State Transfer
SCRA	Small Cell Risk Analysis
SPE	Secure Processing Environment
UX/UI	User Experience / User Interface

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting	3
Afkortingen	4
Inleiding en context	6
Voorwoord	6
De Belgische context en historiek	8
De Europese context	10
Het Gezondheidszorg Data Agentschap	12
Visie en Missie	12
Strategische doelen voor het Gezondheidszorg Data Agentschap	14
Organogram en personeelsbezetting	15
Strategische doelstellingen	16
<i>1.FAIRification</i>	16
<i>2.Data access and sharing</i>	18
<i>3.Data maturity</i>	20
<i>4.Transparency</i>	24
<i>5.HDAB</i>	30
<i>6.Policy</i>	34
<i>7.Management</i>	35



INLEIDING EN CONTEXT

Voorwoord

Beste lezer,

2025 was een scharnierjaar voor het Health Data Agency. Ons agentschap heeft zich in korte tijd ontwikkeld van een jonge organisatie in opbouw tot een stevige pijler binnen het Belgische gezondheidsdata ecosysteem. Met trots kijk ik terug op een jaar waarin we niet alleen onze interne werking hebben versterkt, maar ook een duidelijke meerwaarde hebben gecreëerd voor burgers, zorgverstrekkers, onderzoekers en beleidsmakers.

Dit jaar bouwden we onze nationale datacatalogus verder uit tot 484 FAIR gedocumenteerde dataproducten, conform Europese standaarden. Daarmee zetten we een grote stap richting een transparant, vindbaar en interoperabel datalandschap — een noodzakelijke basis voor kwalitatieve analyses, innovatie en beleid.

Ook op het vlak van data toegang en -uitwisseling maakten we belangrijke vooruitgang. We professionaliseerden het aanvraagproces, introduceerden de rol van Case Manager en migreerden onze opvolging naar een centraal platform. Zo creëren we meer duidelijkheid, snelheid en efficiëntie in elke stap van de data aanvraag.

Onze inzet op transparantie en datageletterdheid kreeg verder vorm via de HDAcademy, waar steeds meer organisaties hun weg naar vinden. Door kennisdeling te versterken, bouwen we mee aan een matuur ecosysteem dat klaar is voor de toekomst. We verstrekten ook onze rol als aanspreekpunt voor gegevenshouders, onderzoekers en nadere partners en creëerden voor elke stakeholder aangepaste informatietools.

2025 was daarnaast ook het jaar van de verdere voorbereiding op de implementatie van de European Health Data Space (EHDS). In samenwerking met verschillende partners wordt de implementatie opgevolgd en behoren we intussen tot de landen die een grote maturiteit behaalden mbt de implementatie.

Tot slot wil ik mijn bijzondere dank uitspreken aan alle collega's die dit jaar hebben bijgedragen aan de realisaties die u in dit verslag terugvindt. Dankzij hun inzet is het HDA vandaag uitgerust om haar opdracht waar te maken: het faciliteren van veilig, betrouwbaar en transparant hergebruik van gezondheids(zorg)data, in het belang van iedereen.

Ik wens u veel leesplezier.

Katleen Janssens

Leidend Ambtenaar

Gezondheids(zorg)data-agentschap (HDA)



HDA

De Belgische context en historiek

In de Algemene Beleidsnota Volksgezondheid van 2 november 2020 stelt de minister van Volksgezondheid de uitwerking van een gezondheidszorgdata-autoriteit (GDA) voor. Later werd de naam aangepast naar gezondheids(zorg)data-agentschap – Agence des données (de soins) de santé (GDA-ADS) en Health Data Agency (HDA) in het Engels. De beleidscel van de minister van Volksgezondheid heeft vervolgens aan FAGG—AFMPS, FOD VVVL—FPS SPSCAE, KCE, RIZIV—INAMI, en Sciensano de opdracht gegeven gezamenlijk een voorstel uit te werken voor het gezondheidszorgdata-agentschap, in overleg met het e-Health-platform.

België heeft een traditie in het verzamelen van vele soorten gegevens over gezondheid op bevolkingsniveau. Gebruik van gezondheidszorg, sterfte, doodsoorzaken, informatie over de sociale zekerheid, klinische gegevens en gegevens over de terugbetaling door de ziekteverzekering worden routinematig verzameld voor het beheer en de werking van de gezondheids- en sociale zekerheidsdiensten. Er worden gezondheidsenquêtes gehouden en surveillancesystemen opgezet op niveau van de bevolking ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid en voor gezondheidsonderzoek. Medische gegevens worden verzameld in speciale medische registers voor de monitoring van ziekten, de kwaliteit van de zorg en onderzoek.

Al deze informatie over de gezondheidstoestand en de gezondheidszorg van de algemene bevolking is echter versnipperd over organisaties en systemen. Hoewel de laatste tien jaar grote vooruitgang is geboekt bij het standaardiseren en vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar maken van deze gegevens, bestond er nog geen geïntegreerd federaal initiatief dat het gebruik en hergebruik van deze gegevens voor het gezondheidsbeleid en voor gezondheidsonderzoek vergemakkelijkt.

In de oorspronkelijke beleidsnota werd voorgesteld om de HDA minstens volgende missies toe te vertrouwen:

- De ontwikkeling van een beleidsstrategie met betrekking tot gezondheids(zorg)data;
- De implementatie van een beleidsstrategie met betrekking tot gezondheids(zorg)data;
- Fungeren als een uniek aanspreekpunt voor gezondheidszorggegevens;
- Het centraal toegankelijk maken van databanken op een GDPR-conforme manier;
- Het ondersteunen van onder meer wetenschappelijk onderzoek en beleidsvoorbereidend werk voor een kwaliteitsvollere en doelmatiger gezondheidszorg.



In het kader van het EU “Resilience and Recovery Fund” (EU-RRF) werd eind 2021 een budget van €7 Mio verkregen voor een Programma voor het opzetten van een Health Data Ecosystem bestaande uit Health Data Governance, Metagegevens Management, Technical Data Capabilities, Dashboards, etc. met als bedoeling een aanzet te geven tot de oprichting van het Gezondheids(zorg)data Agentschap en te voldoen aan de behoeften geformuleerd in de European Health Data Space reglementering.

Op 14 maart 2023 werd de organieke wet voor de HDA goedgekeurd. De HDA moet de transitie van het Belgisch gezondheids(zorg)systeem naar datagedreven zorg ondersteunen. Hierbij staat het beschikbaar maken van gegevens voor beleidsondersteuning, innovatie, onderzoek en productontwikkeling centraal. Het gemakkelijk, uniform, transparant en veilig beschikbaar stellen van gegevens inzake gezondheid in al haar facetten moet leiden tot een meer kwalitatieve, betaalbare, preventieve en gerichte zorg voor elke burger.



De wet voorziet in de oprichting van de HDA als Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie (ADBA). De opdrachten van de HDA omvatten onder andere het faciliteren bij de rechtmatige toegang tot gezondheids(zorg)gegevens en gezondheids(zorg)gerelateerde gegevens, het documenteren en harmoniseren van processen, het verzorgen van een catalogus van de beschikbare types van gegevens, het organiseren van overleg tussen de gegevenshouders en de gegevensgebruikers, en het creëren en het verzekeren van vertrouwen bij de burgers over correct gebruik van hun gezondheids(zorg)gegevens.

Met de organieke wet HDA werd ook een budget voorzien voor de oprichting en werking van de HDA. Deze implementatie van de HDA als organisatie die de taken moet uitvoeren gedefinieerd in de HDA-wet, bouwt verder op de realisaties gedefinieerd in het kader van het Health Data Programma dat in het kader van het EU RRF budget werd uitgewerkt voor 2023 en 2024. Een organogram van de HDA beschrijft de organisatie, rollen en taken die in plaats moet worden gebracht om de opdrachten, zoals bepaald in de wet, van de HDA te kunnen

Vervullen. In 2025 werden de eerste concrete stappen gezet om de werking tussen verschillende instanties beter op elkaar af stemmen. Zo ontstond er een nieuw registerbeleid, uit de nood aan een flexibelere omgang met gezondheidsdata. In plaats van statische registers zal men in de toekomst werken met dynamische, realtime gegevens die veilig uit verschillende databronnen worden opgevraagd bij de gegevenshouders. Dit sluit aan bij de evolutie naar decentraal databeheer en een virtueel geïntegreerd patiëntendossier, waarbij de burger een centrale rol krijgt in het beheer van zijn gezondheidsgegevens. In ditzelfde kader werd beslist om Healthdata.be te integreren in de HDA. Deze integratie werd voorbereid in 2025 en zal vanaf het tweede kwartaal van 2026 in werking treden.

De Europese context

Om optimaal gebruik te maken van het potentieel van gezondheidsgegevens, presenteert de Europese Commissie een verordening tot oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS – European Health Data Space). Deze verordening

- ondersteunt personen die de controle over hun eigen gezondheidsgegevens willen houden;
- ondersteunt de inzet van gezondheidsgegevens voor betere gezondheidszorg, beter onderzoek en betere innovatie en beleidsvorming;
- geeft richtlijnen om in het kader van grensoverschrijdende zorg gezondheidsgegevens veilig uit te wisselen, te gebruiken en te hergebruiken.

De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens is een ecosysteem specifiek op het gebied van gezondheid, dat bestaat uit regels, gemeenschappelijke normen en praktijken, infrastructuren en een bestuurskader, met als doel:

- Mensen mondiger te maken door verbetering van de digitale toegang tot hun elektronische persoonlijke gezondheidsgegevens en de controle daarover, zowel in eigen land als binnen de EU, ondersteuning van het vrije verkeer van die gegevens, en bevordering van een echte eengemaakte markt voor systemen voor elektronische gezondheidsdossiers, relevante medische hulpmiddelen en AI-systemen met een hoog risico (primair gebruik van gegevens) ;
- Te zorgen voor een consistente, betrouwbare en efficiënte opzet voor het gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoek, innovatie, beleidsvorming en regelgeving (secundair gebruik van gegevens).

De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens is dus een belangrijke basis voor een mogelijke Europese gezondheidsunie. Bovendien is dit de eerste gemeenschappelijke gegevensruimte van de EU op een specifiek gebied als gevolg van de Europese datastrategie.

Om de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens tot een succes te maken, moet men gegevenshouders en burgers zekerheid bieden over de verwerking van hun gegevens. De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens biedt dan ook een betrouwbare omgeving waarin specifieke gezondheidsgegevens in alle veiligheid kunnen worden ingezien en verwerkt. Ze is gebaseerd op de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de datagovernanceverordening, de datawet en de richtlijn inzake beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

Deze horizontale kaders voorzien in algemene regels voor alle sectoren. De verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens bevat daarentegen specifiekere regels, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoeligheid van gezondheidsgegevens.







Het Gezondheidszorg Data Agentschap

Visie en Missie

De visie beschrijft de ambities van de HDA en benadrukt het belangrijkste doel ervan. De HDA streeft naar een kwaliteitsvol, data-gedreven gezondheidszorgsysteem, waar gezondheids(zorg)gegevens en gezondheids(zorg)gerelateerde gegevens, op een uniforme, transparante en veilige manier beschikbaar zijn voor secundair gebruik. Hierbij richt de HDA zich op volgende principes:

1. Het faciliteren van de beschikbaarheid van de gezondheids(zorg) gegevens en gezondheids(zorg) gerelateerde gegevens;
2. Het ontwikkelen van veilige en betrouwbare methodes om gezondheidsgegevens uit te wisselen, met aandacht voor cybersecurity;
3. Het ontwikkelen en het implementeren van een beleidsstrategie met betrekking tot gezondheids(zorg)gegevens en gezondheids(zorg) gerelateerde gegevens;
4. Het stimuleren van innovatie, wetenschappelijk onderzoek en beleidsondersteunend onderzoek die kunnen bijdragen tot een hogere kwaliteit, betaalbare, preventieve en doelgerichte gezondheidszorg voor iedere burger en patiënt;
5. Het vertrouwen van burgers en patiënten wordt gewaarborgd door de nadruk te leggen op transparantie en veiligheid rond het hergebruik van gezondheidsgegevens, waarbij de rechten en plichten van de betrokken partijen worden gerespecteerd.



Als antwoord op deze visie heeft de HDA verschillende missies gedefinieerd. Het zal, in samenwerking met regionale en federale gegevenshouders en -gebruikers, de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheids(zorg)gegevens en gezondheids(zorg)-gerelateerde gegevens faciliteren op een vereenvoudigde en meer uniforme, betrouwbare, transparante en veilige manier, door de ontwikkeling van een kader waarin het hergebruik (secundair gebruik) van kwaliteitsvolle gezondheids(zorg)-gegevens en gezondheids(zorg)gerelateerde gegevens optimaal gefaciliteerd wordt. Via de opdrachten zoals beschreven in de wet ondersteunt de HDA het hergebruik van gezondheids(zorg)gegevens en gezondheids(zorg)-gerelateerde gegevens voor bevolkingsbeheer, gezondheidspreventie en gezondheidszorgbeleid gedreven door onderzoek en innovatie, dat uitgaat van de gezondheidsnoden en de actieve rol van de burger en hiermee bijdraagt tot de verbetering van de gezondheid en levenskwaliteit.

Strategische doelen voor het Gezondheidszorg Data Agentschap

Om de visie en missie van de HDA na te streven, zijn volgende strategische doelstellingen gevalideerd door het beheerscomité.

Strategische doelen

1. FAIRification

De HDA zorgt ervoor dat gezondheidsdata in België FAIR zijn (findable, accessible, interoperable, Reusable).

2. Data access and sharing

De HDA faciliteert een efficiënte en doelmatige toegang en uitwisseling van gezondheids(zorg) gegevens en gezondheids(zorg) gerelateerde gegevens voor hergebruik.

3. Data maturity

De HDA streeft naar een verhoogde maturiteit in het ecosysteem op het vlak van data en data geletterdheid.

4. Transparency

De HDA zorgt voor transparantie als basis voor vertrouwen bij alle actoren in het ecosysteem over correct gebruik van hun gezondheids(zorg)gegevens en hun gezondheids(zorg) gerelateerde gegevens.

5. Health Data Access Body (HDAB)

De HDA positioneert zich binnen een interfederale en internationale context als Belgisch aanspreekpunt met betrekking tot secundair gebruik van gezondheidsgegevens en bereidt de implementatie van de EHDS in België voor.

6. Policy

De HDA neemt een actieve rol op inzake beleidsvoorbereiding voor relevante studies en onderzoeken inzake volksgezondheid.

7. Management

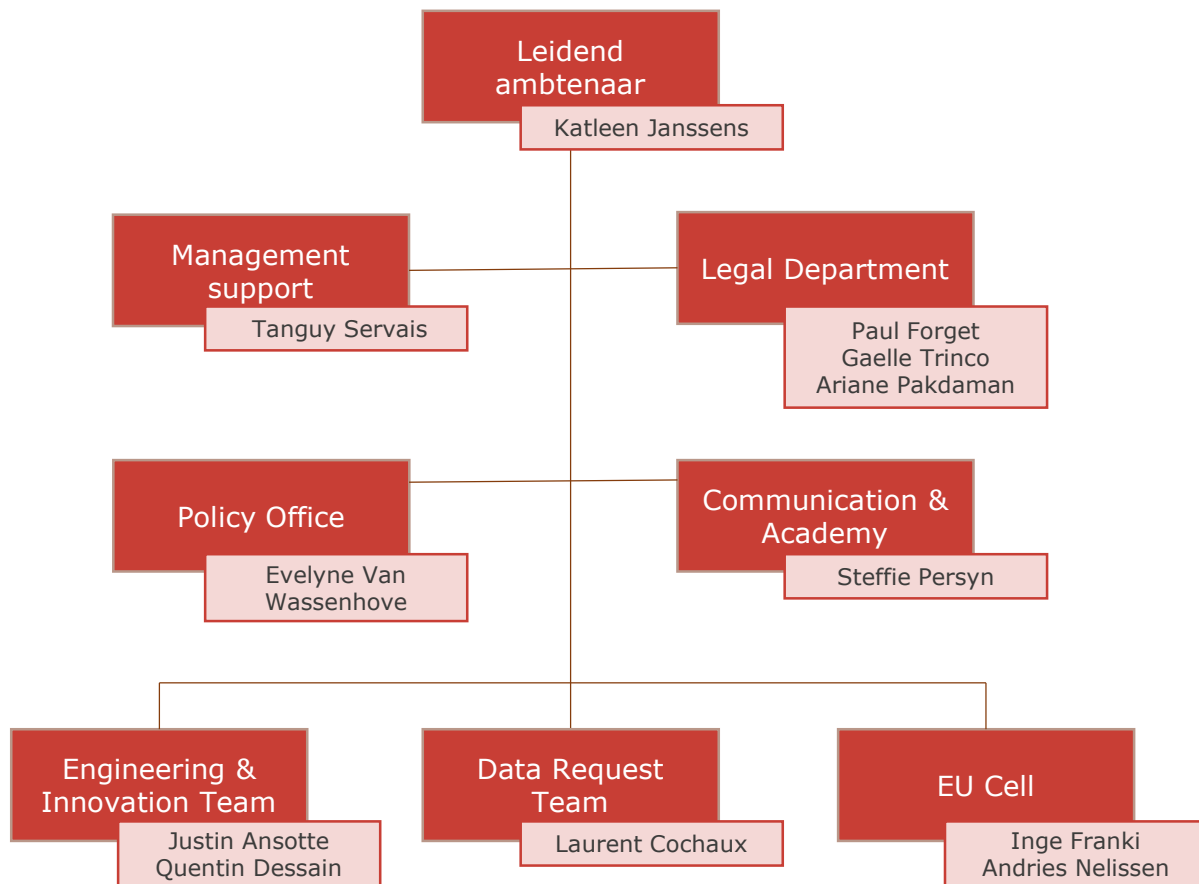
De HDA wordt op een professionele wijze beheerd en gemanaged.

Deze doelstellingen zijn verder vertaald naar een operationeel management plan ter realisatie van de opdracht.

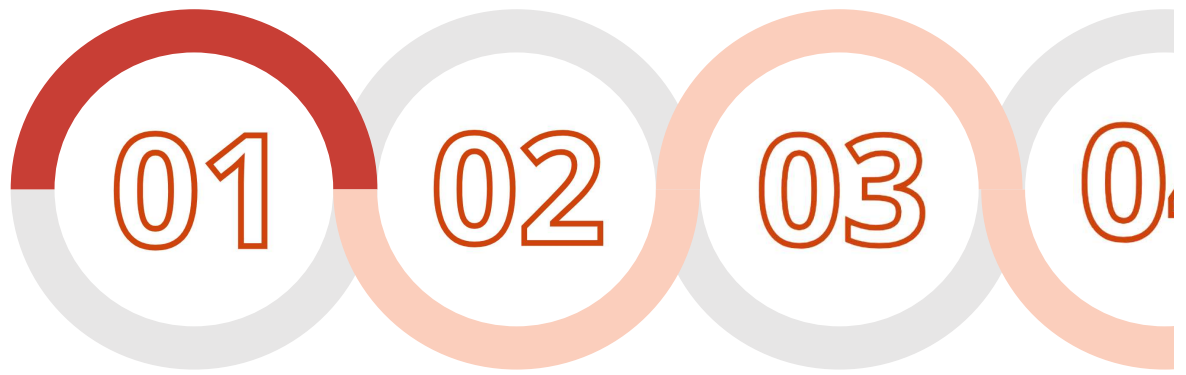
Organogram en personeelsbezetting

In 2025 werd verder ingezet op de operationalisering van het Agentschap, waarbij een bewuste keuze werd gemaakt om het aantal externe medewerkers geleidelijk af te bouwen. Tegelijkertijd werd er sterk ingezet op het aantrekken en aanwerven van vast personeel om de continuïteit en expertise binnen de organisatie te waarborgen.

Door deze aanpak groeide de HDA uit tot een solide en goed gestructureerde organisatie met in totaal 13 medewerkers, zoals weergegeven in het organogram. Deze uitbreiding stelde het Agentschap in staat om haar taken efficiënter en effectiever uit te voeren, met een team dat beter op elkaar was afgestemd en over de benodigde kennis en vaardigheden beschikte.



Begin 2026 wordt het personeelsplan verder uitgevoerd en zullen onder meer 10 vacatures gepubliceerd worden voor Administratief Assistent, Project & Program Manager, Account Budget Manager, Data Governance Specialist, Platform & Integration Engineer, Data Scientist, Communication Manager, UX/UI Specialist en copywriter.



Strategische doelstellingen

1. FAIRification

Datacatalogoog

Het afgelopen jaar heeft de HDA haar werk voortgezet om de inventaris van datasets binnen de oprichtende organisaties te verrijken. Dit heeft het aantal dataproducten verhoogd van 401 naar 484. Deze sets zijn momenteel gedocumenteerd in de DataHub-catalogus, in alle drie de landstalen, en in overeenstemming met de FAIR-principes en de DCAT-AP-standaard voor gezondheid (HealthDCAT-AP).

Deze norm heeft in het afgelopen jaar verschillende wijzigingen ondergaan en is het intellectuele eigendom van de Europese Commissie geworden. De HDA werkt eraan om de metadata up-to-date te houden en eventuele afwijkingen van nieuwe versies van de standaard te identificeren.

Er werden drie workshops gehouden om onderhoudsprocessen voor de HDA Data Catalogue woordenlijst te definiëren met de oprichtende organisaties. Er is een hybride aanpak gedefinieerd, gebaseerd op samenwerking tussen het HDA Data Content Team en werkgroepen bestaande uit gegevenshouders.

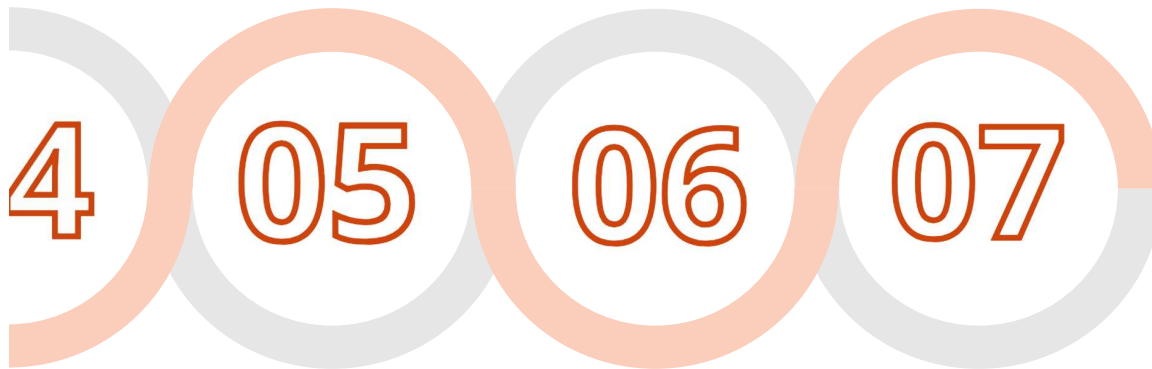
Er is een chatbot geïmplementeerd in de catalogoog die zoekopdrachten in natuurlijke taal mogelijk maakt. Deze is gebaseerd op een Retrieval-Augmented Generation-technologie gebaseerd op het GPT-5 taalmodel.

De Colibra-tool is geïntegreerd in het HDA-softwarelandschap. Er werd een roadmap van 12 maanden gevolgd om de tool te configureren en de metadata naar het nieuwe platform te migreren. Een Asset Model for Healthcare werd ontwikkeld, geleid door verschillende oprichtende organisaties, om een model te definiëren dat compatibel is met HealthDCAT-AP en een gefedereerde visie op de architectuur, waarbij meerdere instanties worden benut die een woordenboek en woordenlijst delen via een interoperabiliteitslaag.

Als onderdeel van het HeDERA-project is er ook een triple store ingezet als database voor RDF-bestanden. De open source GraphDB-technologie werd in deze fase gekozen.

Een Belgische specifieke HealthDCAT-AP validator is ook ingezet en wordt nu gehost op de European Test Bed-service. Het maakt geautomatiseerde implementatie en volledige aanpassing van de SHACL-bestanden die voor metadatavalidatie worden gebruikt, mogelijk.

Ten slotte worden deze nieuwe componenten geïntegreerd in een nieuwe metadata-opnameservice die momenteel in ontwikkeling is. Dit stelt gegevenshouders in staat hun metadata autonoom naar de HDA te verzenden, terwijl de validatie van hun naleving en de identiteit van de zender wordt gegarandeerd.



Datakwaliteit

Om de datakwaliteit te verbeteren, zijn er richtlijnen ontwikkeld om gegevenshouders te helpen het QUANTUM Data Quality and Utility Label toe te passen, met name voor de technische dimensies. Om hen hierbij te ondersteunen, zijn er ook sjablonen ontwikkeld om de implementatie ervan te vergemakkelijken.

EU-paraatheidsonderzoek

De HDA heeft een vragenlijst ontwikkeld om het voorbereidheidsniveau van Belgische ziekenhuizen voor het beheer van gezondheidsgegevens in overeenstemming met de eisen van de European Health Data Space (EHDS) te beoordelen.

Deze vragenlijst is het resultaat van een combinatie van verschillende bestaande initiatieven (EHDS Readiness, Data Maturity Assessment, enz.) en behandelt de thema's governance en databeheer, datakwaliteit, metadata, interoperabiliteit, beveiliging, secundair gebruik, kennis en vaardigheden, transparantie en architectuur.

IT architectuur

Er werd een architectuurplan gedefinieerd voor de applicaties die nodig zijn voor de juiste werking van het agentschap. Continue integratie- en implementatietools (CI/CD) zijn opgezet met ondersteuning van FOD VVVL, om de implementatie van applicaties volgens een GitOps-aanpak en op Kubernetes-clusters mogelijk te maken. De HDA-applicaties werden geleidelijk gemigreerd naar dit nieuwe platform, via ArgoCD, volgens het App of Apps-patroon.

Hiernaast werd ook de Matomo-tool geconfigureerd om de analyse van verkeer op de website en de HDA-catalogus mogelijk te maken.

Ten slotte zette de HDA zijn verkennend werk voort aan veilige verwerkingsomgevingen (SPE's), via zijn speciale werkgroep, uitwisselingen met Europese partners, evenals binnen het kader van het HeDERA-project, om de behoeften, processen en bijbehorende gebruikssituaties te identificeren.

Agile werkwijze

Het HDA IT-team organiseert het beheer van zijn projecten volgens agile praktijken, door het werk te structureren rond de Jira-tool en door de documentatie te centraliseren op een Confluence-ruimte.

Verkenningproject

Er werd een tool ontwikkeld om HealthDCAT-AP-conforme metadata in RDF-formaat te genereren uit ongestructureerde documentatie. Deze tool heeft een visuele interface en een API-toegangspunt gebaseerd op een REST-architectuur.

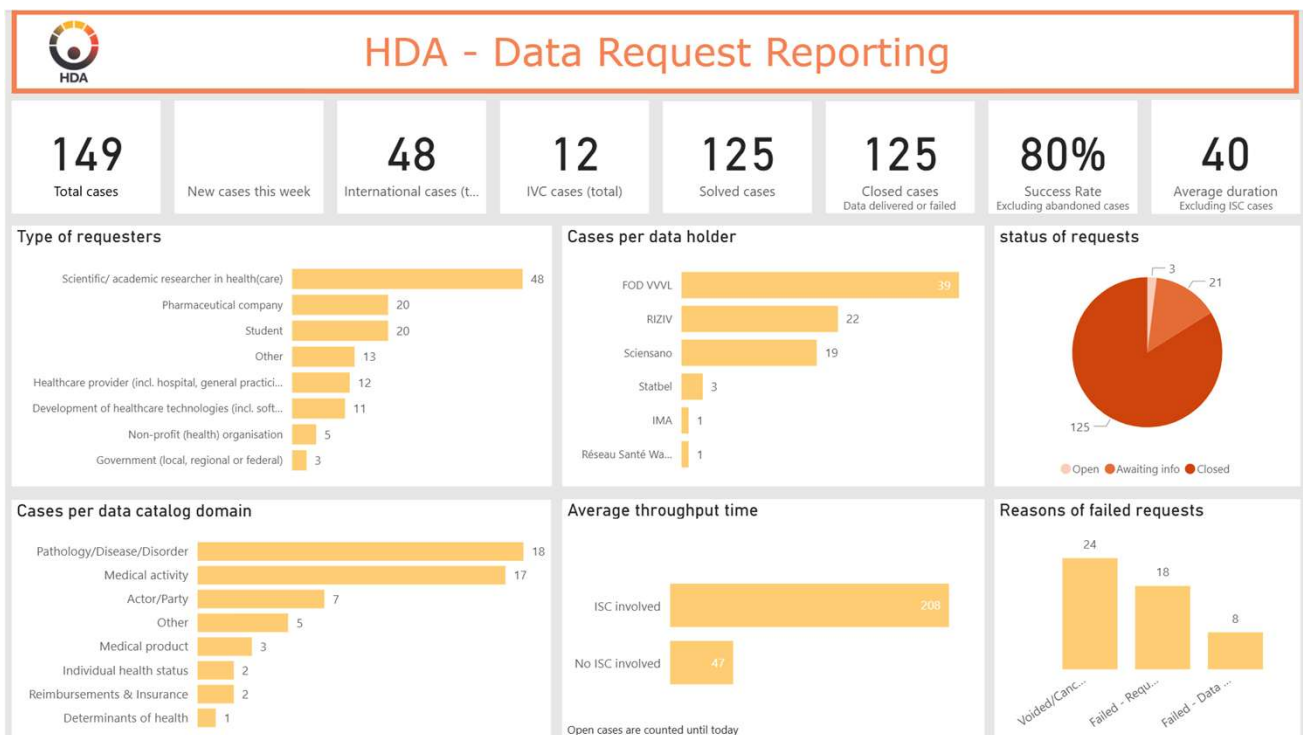


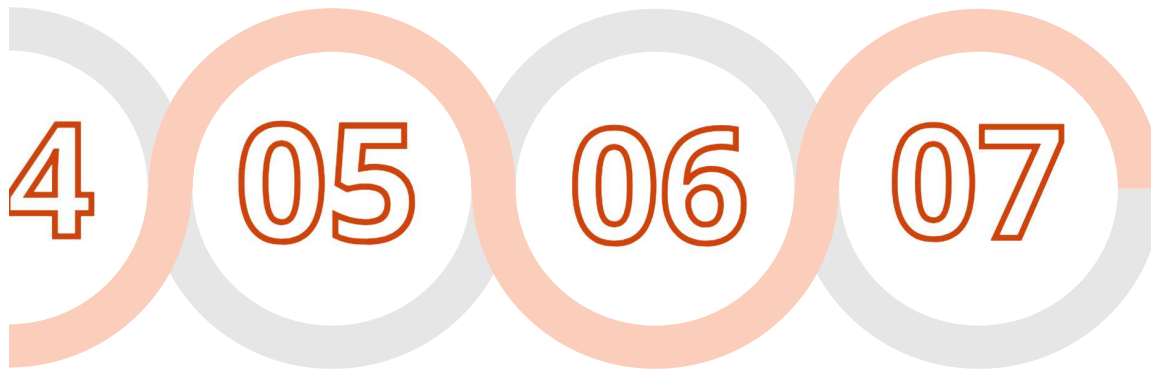
2. Data access and sharing

In 2025 heeft het agentschap haar capaciteit voor gegevensdeling en verzoekbeheer aanzienlijk versterkt. Zo werd begin juni 2025 de eerste Case Manager aangesteld. Deze heeft de verantwoordelijkheid genomen over alle activiteiten met betrekking tot "Data Request Management". Deze functie heeft het mogelijk gemaakt om de verwerking van verzoeken verder te structureren, de opvolging te verbeteren en een duidelijk en geïdentificeerd aanspreekpunt voor belanghebbenden te bieden.

In de loop van het jaar is het agentschap overgestapt op "ServiceNow" als centraal case management-instrument. Alle oude en "in uitvoering" aanvragen zijn naar dit platform overgezet. Daarnaast is het online formulier ook gekoppeld aan dit platform. Elke online gevalideerde aanvraag wordt automatisch naar "ServiceNow" gestuurd voor verwerking. Dit maakt duidelijke en efficiënte opvolging van verzoeken mogelijk. Dat laatste wordt aangepast en verbeterd naarmate we vorderen. Aangezien de Europese wetgeving nog steeds fluctueert, moet het HDA haar werkwijze ook aanpassen. Deze tool hielp de continuïteit van de service te waarborgen en verhoogde de efficiëntie en transparantie van het beheer van gegevensverzoeken. Alle verzoeken worden via dit hulpmiddel gedaan en de hoofdgegevenshouders kunnen aanvragers die bij hen komen ook naar het online formulier doorsturen.

Enkele cijfers over de verzoeken die door de HDA zijn ontvangen:





Hiernaast werden diverse analyses uitgevoerd om een beter begrip te krijgen van het landschap van "health data request processing" bij de belangrijkste gegevenshouders.

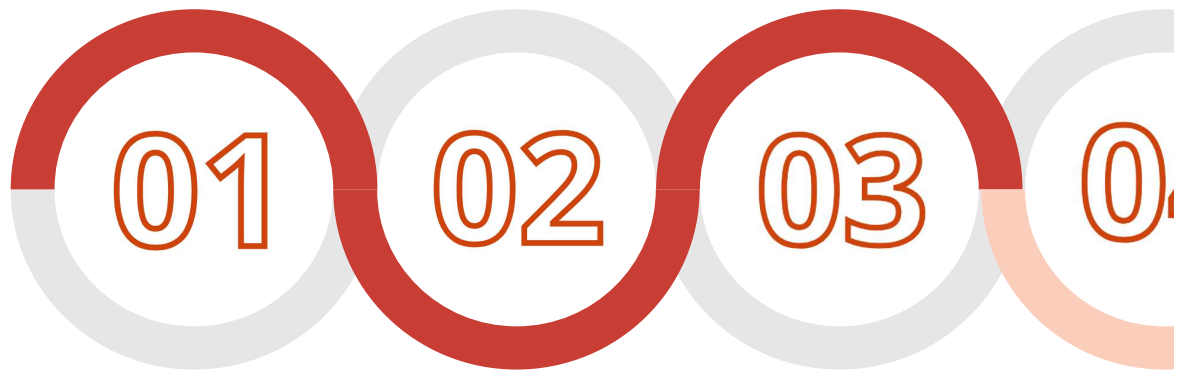
Er is een analyse uitgevoerd van de "AS IS" situatie, op basis van interviews met verschillende personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van gegevensverzoeken binnen FOD VVVL, RIZIV, Sciensano, IMA, StatBel en BCR. Op basis van deze interviews werd een rapport opstellen over de huidige algemene werking van de verwerking van gegevensverzoeken binnen deze instanties. Het maakte het ook mogelijk om de huidige datastromen en de uitdagingen waarmee deze instanties worden geconfronteerd te begrijpen. De lessen die getrokken werden uit deze analyse, worden toegepast binnen de HDA.

Er is een procesanalyse begonnen om een Small Cell Risk Analysis (SCRA) uit te voeren binnen de HDA. Dit zou het ook mogelijk moeten maken om de bestaande datastromen beter te begrijpen, maar ook om de vaardigheden te begrijpen die nodig zijn om deze analyse uit te voeren. De HDA moet zich kunnen positioneren op dit aspect van de verwerking van dataverzoeken om te weten hoe deze stap van het beheren van dataverzoeken eventueel in haar interne verwerkingsstroom geïntegreerd kan worden. Deze fase is momenteel een bottleneck in het bredere gezondheidsdatalandschap, die we hiermee proberen op te lossen.

Er is ook een analyse begonnen van de processen met betrekking tot beraadslagingen door het IVC ("Informatieveiligheidscomité"). Het doel is om het werk, de stromen en het functioneren van het IVC te begrijpen. Deze stap is belangrijk omdat de EHDS het delen van bepaalde gegevensverzoeken afhankelijk maakt van het verkrijgen van een vergunning. Dit proces en deze vergunning lijken sterk op het proces dat in België al bestaat om de instemming van het IVC te verkrijgen. Het is daarom belangrijk om deze flow te begrijpen om de implementatie van de EHDS zo vlot mogelijk te laten verlopen. Bovendien is deze fase momenteel ook een knelpunt dat op lange termijn opgelost moet worden. Het HDA is als HDAB verantwoordelijk voor het uitgeven van de vergunning aan de aanvrager. Hiervoor is nauwe samenwerking met het IVC noodzakelijk. Deze analyse zal een beter begrip en vaststelling van rollen en verantwoordelijkheden bieden.

Al deze analyses maken het mogelijk om informatie uit het landschap te verzamelen binnen organisaties die al uitgebreide ervaring hebben met het verwerken en delen van gezondheidsgegevens. Deze belangrijke informatie zal helpen om een betere strategie en actieplan voor de komende jaren op te stellen met betrekking tot het beheer van dataverzoeken.

Ten slotte moet het agentschap zijn rol van coördinatie tussen de verschillende agentschappen vervullen in de context van complexe projecten waarbij meerdere gegevenshouders betrokken zijn. Om deze reden is er een terugkerende vergadering geregeld met de belangrijkste gegevenshouders. Tijdens deze bijeenkomst worden complexe gegevensverzoeken besproken met de verschillende belanghebbenden (een complex verzoek betreft vaak verschillende gegevenshouders). Deze bijeenkomst dient als platform voor gegevenshouders om uit te wisselen over de verzoek, de gevraagde gegevens, gegevensverwerking, pseudonymisatie of anonimisatie,...) om de aanvrager een uniforme en gecoördineerde feedback te geven. Dit zorgt voor meer efficiëntie en afstemming in de opvolging van deze complexe aanvragen. Deze vergaderingen moeten ook leiden tot betere documentatie van ieders datastromen en tot standaardisatie van bepaalde procedures.

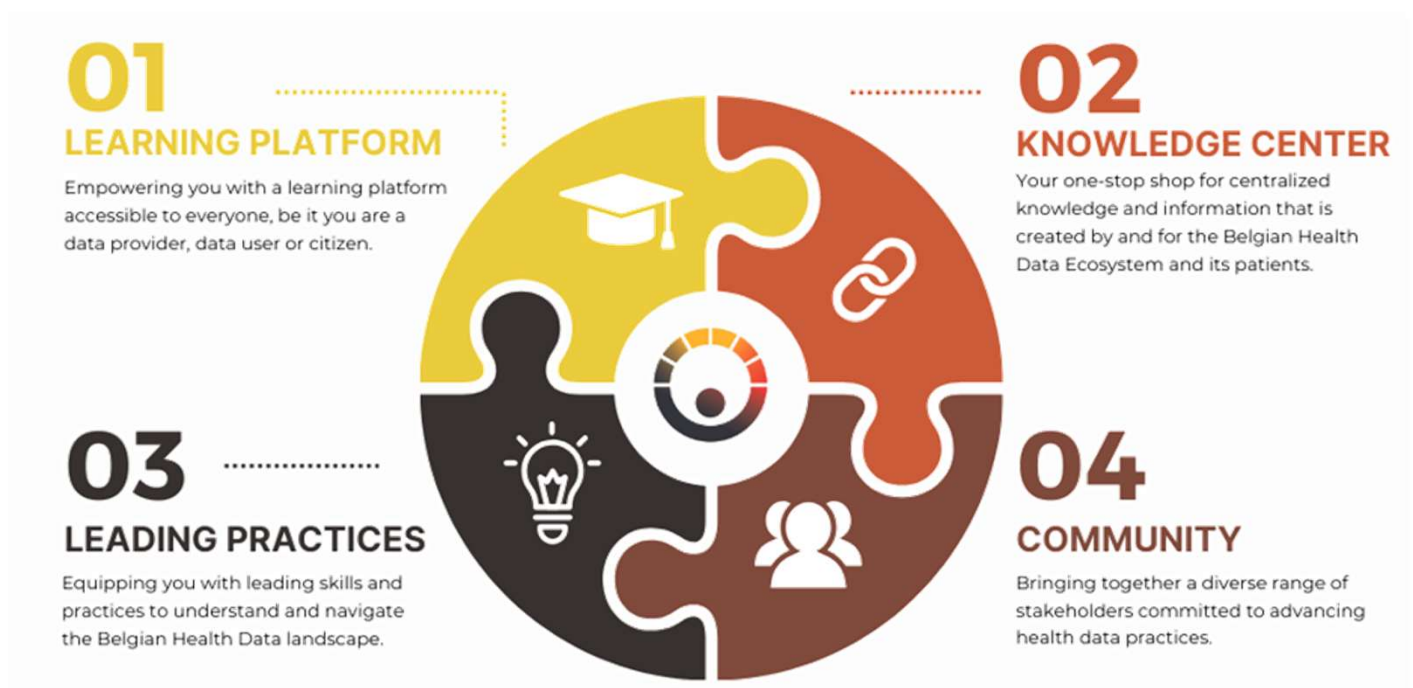


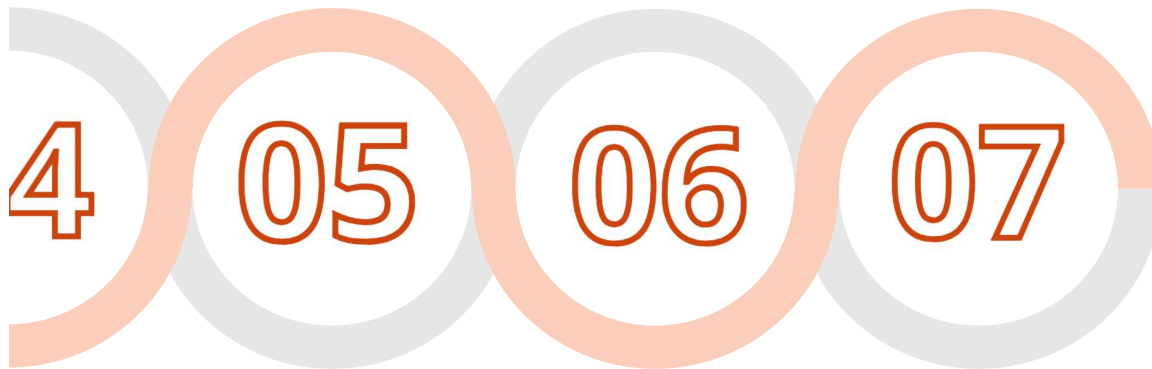
3. Data maturity

De voornaamste doelstelling van de HDAcademy is om de datageletterdheid van het Belgische gezondheidsecosysteem te verbeteren. Tot dit ecosysteem behoren data holders, data users, zorgverstrekkers, patiënten, burgers en overheidsbeleidsdiensten.

Om dit doel te bereiken, zet de HDAcademy in op 4 pijlers, waarbij de HDAcademy fungeert als:

1. een leerplatform dat informatie en kennis ter beschikking stelt en toegankelijk maakt voor zowel data holders, data users, burgers als overheidsbeleidsdiensten.
2. een kenniscentrum dat informatie en kennis rond gezondheidsdata en bijhorende relevante praktijken wil centraliseren.
3. een aanbieder van goede kennis en praktijken waardoor deze worden samengebracht en gedeeld, om bij te dragen aan een collectief begrip en hoge datageletterdheid voor het Belgische gezondheids-(data)landschap.
4. een gemeenschap, waarbij de verschillende stakeholders en experts met elkaar in contact kunnen treden en ervaringen kunnen uitwisselen. De HDAcademy werkt hiervoor samen met verschillende experts om informatie en opleidingen op maat aan te bieden.





De HDAcademy bestaat uit een **online leerplatform** met opleidingsmateriaal in diverse formats. Deze Academy is toegankelijk via de directe link (<https://academy.hda.belgium.be/?lang=nl>) of via doorverwijzing vanaf de HDA-homepagina. Het leerplatform maakt gebruik van het Moodle Learning Management System (LMS) waarbij Cblue verantwoordelijk is voor de hosting en onderhoud, en SMALS technische ondersteuning en begeleiding biedt.

In 2024 werden de opleidingen ingedeeld in 5 opleidingsdomeinen: health data landscape (algemene informatie over het gezondheidsdatalandschap), legal frameworks and policies (wettelijk kader, regelgeving en beleid), HDA services (diensten en activiteiten van de HDA), (meta)data (beheer van metadata) en tot slot analytics & AI (data analyse en Artificiële Intelligentie). In 2025 hebben we onze leer- en ontwikkelstrategie verder geprofessionaliseerd. Waar we vroeger werkten met brede, algemene leerdomeinen, schakelden we over naar specifiekere en doelgerichte leerdomeinen. Deze verfijning van leerdomeinen zorgt voor meer helderheid, consistentie en toegankelijkheid. Dit vormt een belangrijke basis in gebruikerservaring om bezoekers gericht te begeleiden naar opleidingsmaterialen op maat.

01

HDA-informatie

Opleidingsmaterialen over de activiteiten en dienstverlening die HDA aanbiedt aan alle stakeholders

02

Algemene informatie

Opleidingsmaterialen met algemene basisprincipes over het gezondheids(data)-landschap

03

Professionals

Opleidingsmaterialen gericht op alle professionele profielen die in aanraking komen met gezondheidsgegevens

04

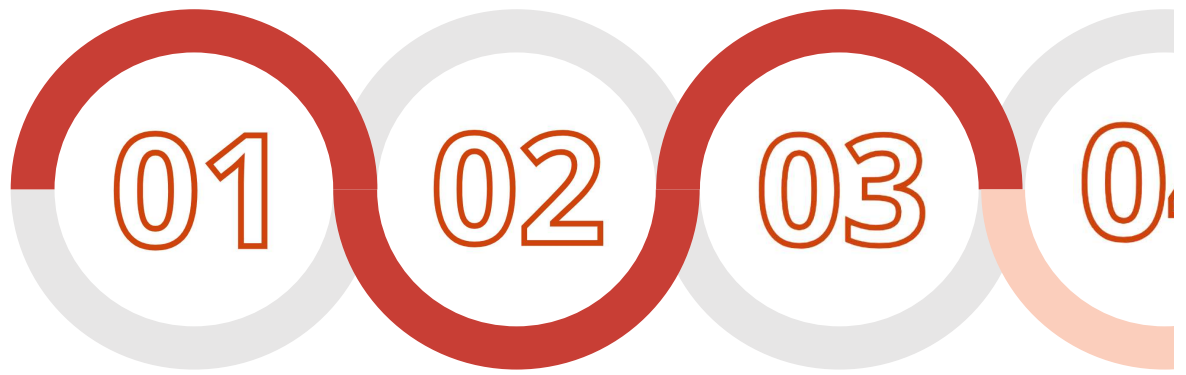
Wettelijk kader en beleid

Opleidingsmaterialen over nationale en Europese regelgeving, wettelijke kaders en juridische aspecten

05

Analyse & AI

Opleidingsmaterialen over data-analyse en de ontwikkelingen van AI in het gezondheids(data)landschap



De Health Data Academy (HDAcademy) werd op 17 januari 2024 opgericht. Bij de lancering telde de HDAcademy opleidingscatalogus 9 opleidingen. Ondertussen is de catalogus sterk uitgebreid. Doorheen 2024 werden nog 5 nieuwe Engelstalige opleidingen toegevoegd, gaande van algemene modules tot meer technische modules. In 2025 werden er **6 unieke opleidingen** toegevoegd, waarvan 2 opleidingen eveneens vertaald zijn naar Frans en Engels. Zo is er een opleiding die een introductie geeft tot datageletterdheid, er zijn webinars van de Europese Commissie over de technische en specifieke toelichting van de EHDS, een Nederlandstalige en Franstalige basisopleiding over de EHDS die de algemene basisprincipes toelicht vanuit verschillende invalshoeken, een strip over toegang tot gezondheidsgegevens in Nederlands, Frans en Engels en tot slot een module over datasolidariteit.

Daarbij werd ook een **nieuw leerformaat** toegevoegd aan de opleidingscatalogus. Zo verscheen er naast traditionele e-learnings ook een podcast over datasolidariteit. Het aanbod aan verschillende leerformaten zal in 2026 ook nog verder uitgebreid worden.

Sinds oktober 2025 voorziet de HDAcademy nu ook een aparte categorie rond **bijdragen van partners**. Er werden 5 bijdrages toegevoegd van partners, gaande van brochures tot papers en richtlijnen.

Begin december 2024 werd het eerste artikel binnen de **Health Data Talk Series** gelanceerd. Het allereerste artikel over de waarde van secundair gebruik van gezondheidsgegevens is het resultaat van een constructieve samenwerking met verschillende stakeholders, zijnde APB, Patient Expert Center, KULeuven, pharma.be, Kabinet Volksgezondheid, beMedTech, Koning Boudewijnstichting, Sciensano en Universiteit Gent. In 2025 werden nog 9 artikels toegevoegd aan deze reeks, waaronder een artikel gewijd aan de ondersteunende rol van de HDA in de gegevensreis van de data user.

Als we alles bij elkaar nemen, telt de HDAcademy in totaal **46 leermaterialen** in 2025.



Webinars EHDS

-

The European Commission explains the regulation in 3 webinars.



L'HDA explique: l'EH

-

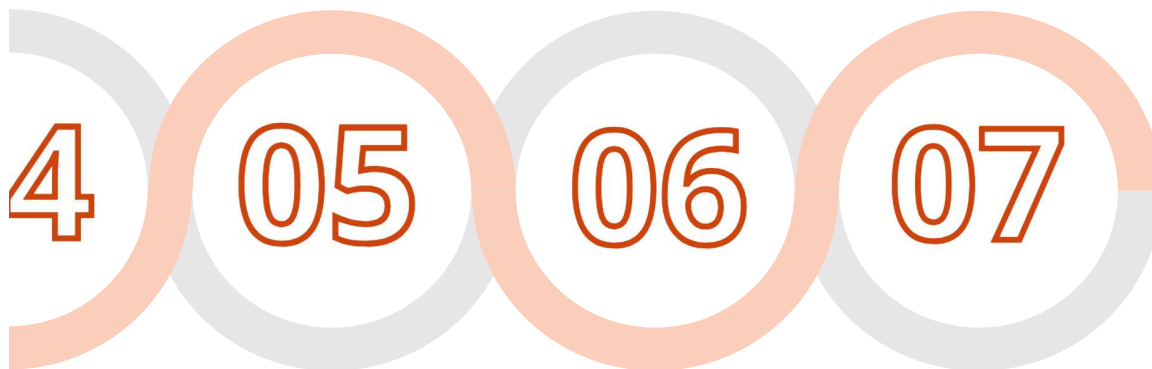
L'HDA explique la législation avantages sur la base d'exem



Podcast: the concept of Data Solidarity

-

This learning contains the data solidarity podcast audio file and the brochure.



Er zijn continue **optimalisaties** aan de homepage en het Learning Management Systeem (LMS) om in lijn te blijven met de huidige standaarden. Zo is er een banner toegevoegd met aankondigingen om opleidingen te promoten of om evenementen in de kijker te zetten. Het welkomstwoord en de toelichting van de opleidingsmaterialen werden herschreven om ze beknopter en toegankelijker te maken. Vervolgens bevat de homepage nu ook een onderverdeling in verschillende doelgroepen die rechtstreeks leiden naar opleidingsmaterialen op maat van deze doelgroep. Daarnaast is er nu ook de optie om door het volledige opleidingsaanbod te bladeren of gericht te zoeken met filters.

Elke cursus bevat nu ook een alinea met cursusinformatie, zoals de taal, het doelpubliek, het lesdoel en de tijdsinvestering om de module te doorlopen. Dankzij deze informatie krijgen bezoekers een goed beeld van het opleidingsmateriaal en kunnen ze inschatten of dit overeenstemt met hun verwachtingen.

Tot slot is de toegankelijkheidsverklaring online die aangeeft hoe toegankelijk en inclusief de HDAcademy is. Ook in 2026 zullen bijkomende inspanningen voorzien worden om de toegankelijkheid en inclusie te verhogen.



01

02

03

04

4. Transparency

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een intensivering en professionalisering van de communicatieactiviteiten van de Health Data Agency. In de context van de geleidelijke implementatie van het EHDS heeft communicatie een belangrijke rol gespeeld bij het informeren, geruiststellen en ondersteunen van alle belanghebbenden: gegevenshouders en gebruikers, burgers, publieke instellingen, gezondheidsprofessionals en Europese partners.

De communicatiestrategie was gebaseerd op twee doelstellingen:

1. Het vergroten van de zichtbaarheid en het begrip van de missie van de HDA, zowel op nationaal als Europees niveau;
2. Bewustzijn vergroten over de impact van EHDS binnen het HDA-ecosysteem, met de nadruk op zorgprofessionals en IT-leiders.

Het jaar werd gekenmerkt door een aanzienlijke versterking van de publieke aanwezigheid van de HDA:

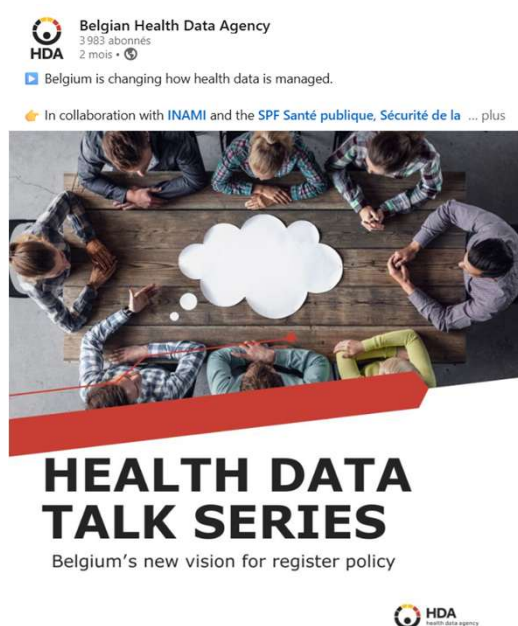
Persrelaties

De HDA is verschenen in verschillende gespecialiseerde media, zoals MediQuality, Zorgnet-Icuro, waarin haar rol in het beheer van gezondheidsdata wordt benadrukt. Deze publicaties helpen het agentschap te verankeren als centrale speler in het Belgische landschap.



Sociale media

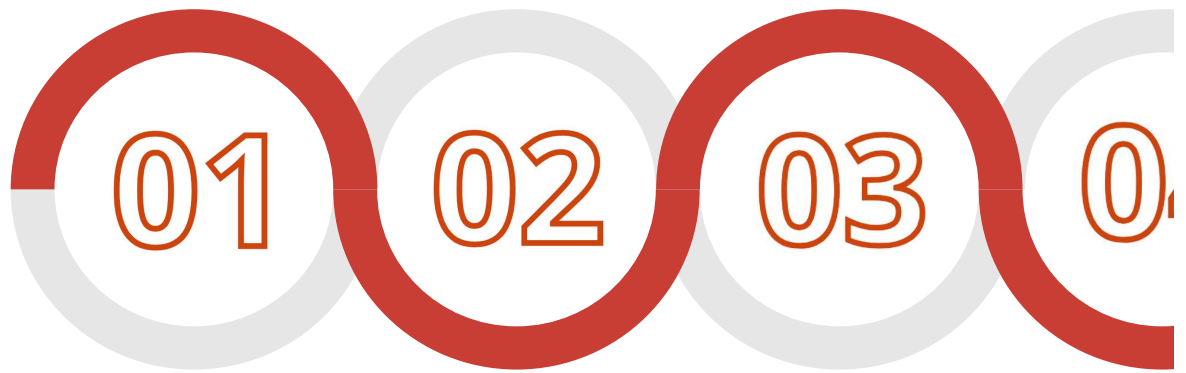
De LinkedIn-pagina is blijven groeien en heeft het aantal volgers uitgebreid. Publicaties omvatten nieuws en institutionele communicatie met betrekking tot HDA-activiteiten. Het doel blijft om een regelmatige, informatieve en toegankelijke aanwezigheid te behouden.



Communicatie rond de EHDS

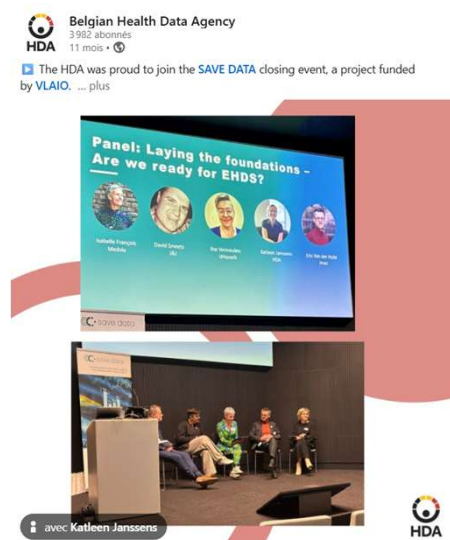
De EHDS heeft een centrale plaats ingenomen in de communicatieacties.

- Een speciale EHDS-pagina is herschreven op een meer educatieve manier om het makkelijker te maken een complex onderwerp te begrijpen.
- Workshops en informatiesessies werden georganiseerd met federale diensten, partnerinstellingen en professionals in de sector om de juridische, technische en operationele implicaties van het EHDS te verduidelijken.



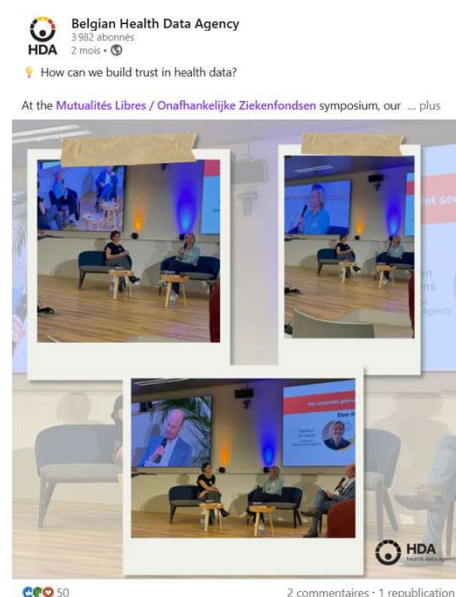
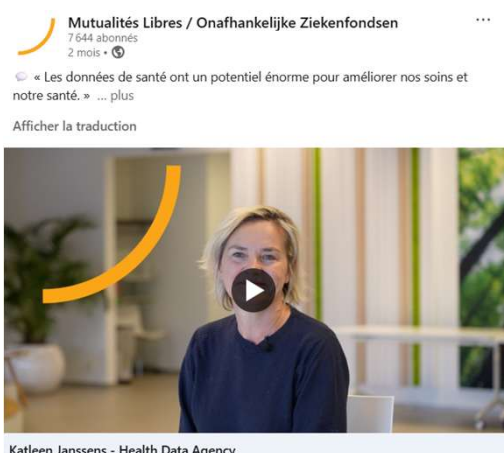
Evenementen

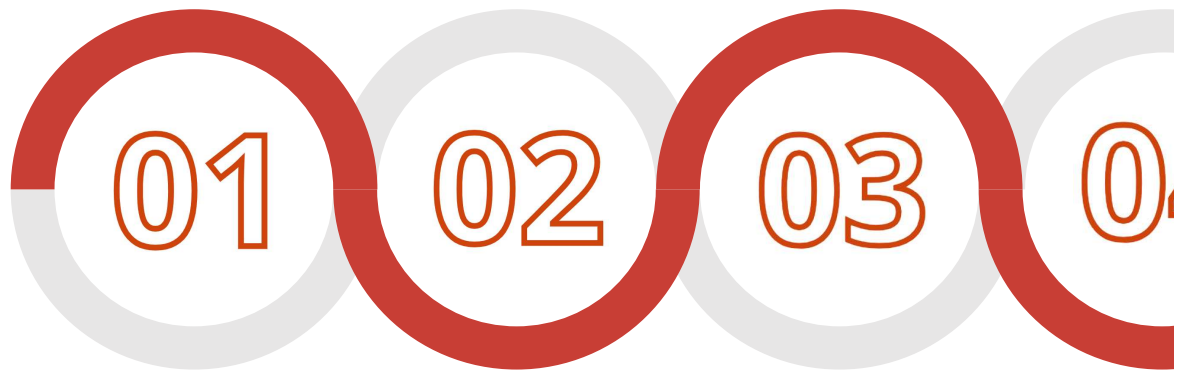
Het jaar werd gekenmerkt door een reeks evenementen die de expertise van de HDA benadrukten. De HDA-teams zijn het hele jaar door sterk gemobiliseerd. Collega's hebben het agentschap vertegenwoordigd op een breed scala aan evenementen, conferenties, workshops en panels, waarmee zij hun expertise en betrokkenheid bij de missie van de HDA hebben getoond. Hun actieve deelname heeft geholpen om de aanwezigheid van het agentschap in het ecosysteem van gezondheidsdata te consolideren en de samenwerking met nationale en Europese partners te versterken.



Communicatie- en samenwerkingsprojecten

In het afgelopen jaar ontwikkelde de HDA een samenwerking met de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waardoor de zichtbaarheid onder zorgverleners en het algemene publiek werd versterkt. Deze samenwerking resulteerde in de mede-creatie van een tweetalig artikel (FR/NL). Het doel van deze publicatie was om de missie van de HDA te presenteren, het belang van het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens, evenals de voordelen voor mantelzorgers en patiënten. Na deze vruchtbare redactionele samenwerking met de Onafhankelijke Ziekenfondsen is de relatie tussen de twee organisaties verder versterkt. De Onafhankelijke Ziekenfondsen nodigden de directeur van het agentschap, Katleen Janssens, uit om te spreken op hun symposium. Ze nam deel als lid van een expertpanel en bracht het strategische perspectief van de HDA op het secundaire gebruik van gezondheidsdata mee.





Transparency in cijfers

De HDA nam actief deel aan 20 events over gezondheidsdata in 2025, als spreker, panellid of deelnemer.

Enkele voorbeelden:

- 3 daagse masterclass 17-19/11 van klinische data naar AI - RADar AZ Delta
- Eerste Agoria Healthtech werkgroep over 'secundair gebruik van gezondheidsgegevens in België
- Building Bridges: Unlocking the Power of Shared Health Data
- Lunch & Learn - data literacy bij zorgverleners
- Driving Innovation in Health Data and Digital Health
- Health Data Summit (i-HD)
- The development of cross-border health services in e-Health from the EU citizens' perspective. Chances and challenges' – conference
- The Role of Digital Medtech in EHDS
- 18th European Public Health Conference 2025
- Symposium van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

EVENTS & SPEECHES

20+

deelnames evenementen

1

symposium

WEB

Tussen 01/01/2025

21.0

bezoeken

83

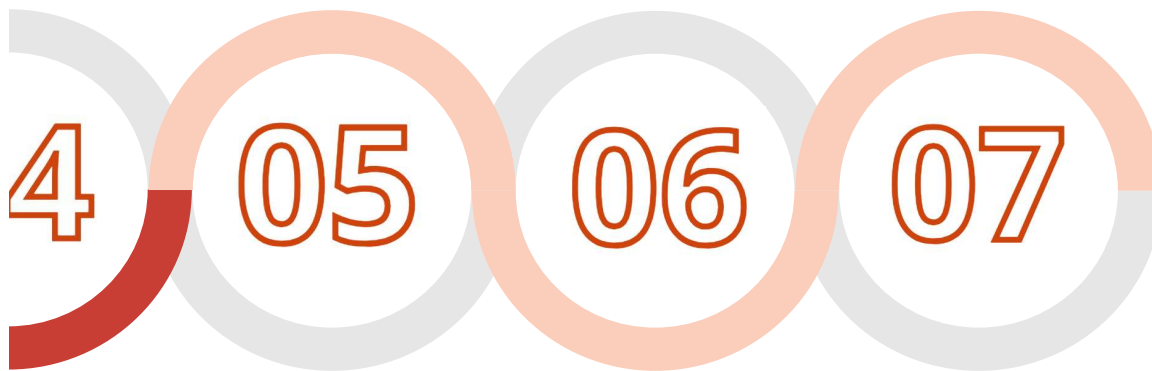
kliks naar de

69

kliks naar de

2.6

kliks naar onze vacatures



Het voorbije jaar bevestigde de centrale plaats van communicatie in de missie van de HDA: informeren, organisaties ondersteunen, de implementatie van het EHDS ondersteunen en transparantie voor burgers garanderen.

De genomen acties hebben het mogelijk gemaakt:

- de zichtbaarheid van het agentschap vergroten;
- het begrip van het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens versterken;

SITE

5 en 01/12/2025:

611

ekers

39

e catalogus

92

HDAcademy

585

iturebeschrijvingen

LINKEDIN

Tot 31/12/2025:

57

reposts

3376

reacties

153.058

impressies



5. HDAB

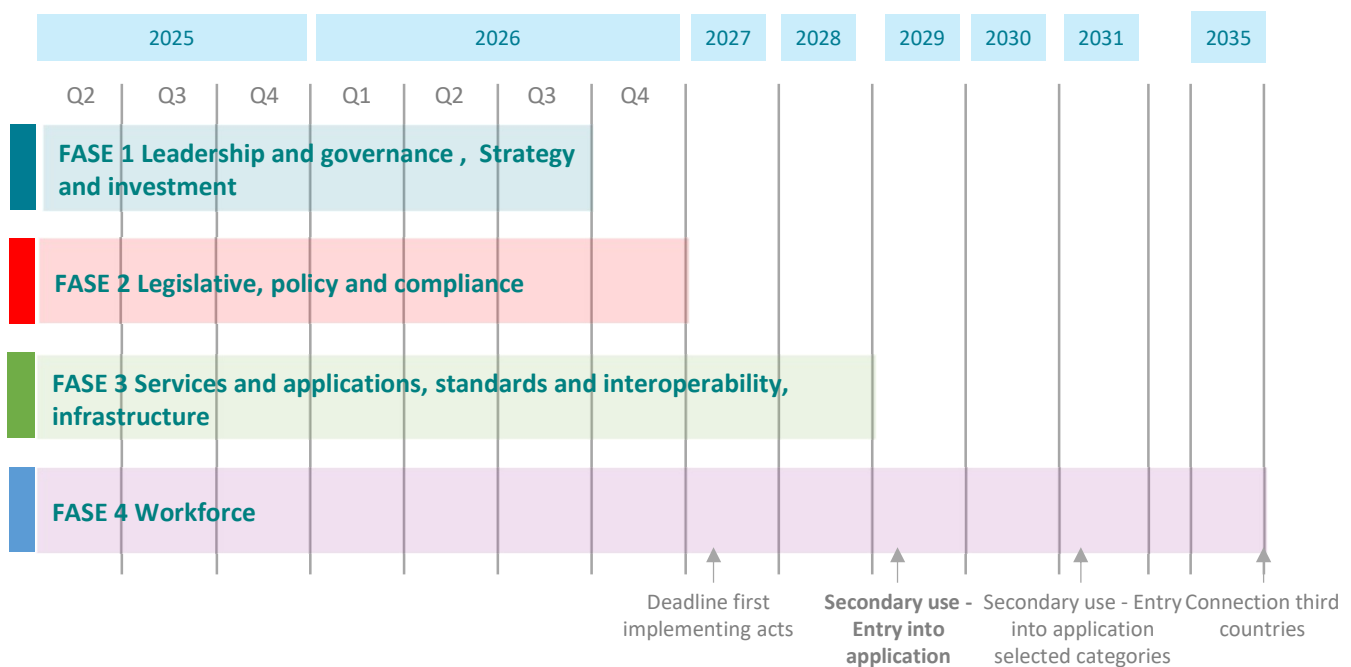
De implementatie van de **EHDS-regelgeving in België** is voorzien in verschillende fasen, gebaseerd op de verschillende dimensies voorzien in het ontwikkelingsmodel voorgesteld door de Europese Commissie, nl het zogenaamde 'maturity model'. Dit model voorziet de volgende dimensies:

Fase 1 - Leiderschap, beleid en bestuur en rolverdeling

Fase 2 - Wetgeving en rechtsgronden

Fase 3 - Dienstverlening, infrastructuur, processen en standaarden

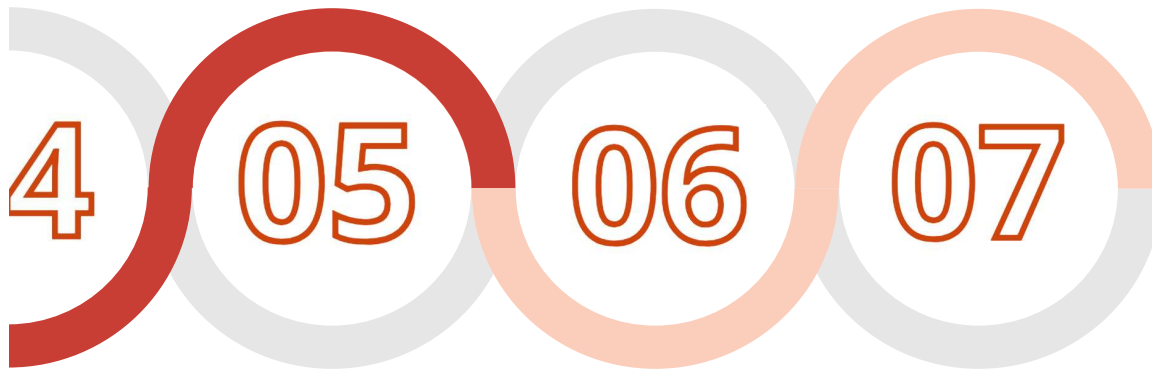
Fase 4 - Expertise en tewerkstelling



Rekening houdend met deze planning, was er in 2025 een grote focus op de voorbereidingen rond governance en rolverdeling. (**fase 1**).

Betreffende de **functies van de HDA**, werden de voorbereidingen genomen om tot een politieke beslissing te komen over de volgende punten:

- De aanstelling van de HDA als coördinerende maar ook enige HDAB in België.
- Aanstelling van de HDA als nationaal contactpunt met de central services van de Europese Commissie, d.w.z. dat internationale gegevensaanvragen via de HDA zullen verlopen en dat de HDA de verbinding zal opzetten met de centrale catalogus van de Europese Commissie.
- Eerste discussies rond de uitwerking van de HDA als interfederaal agentschap.
- De rechtstreekse samenwerking van de HDA met het informatieveiligheidscomité (IVC) voor het afleveren van de goedkeuring tot toegang tot gezondheidsdata voor secundair gebruik.



Daarnaast werd er ook gewerkt rond de **integratie van de HDA in het nationaal netwerk** voor secundair gebruik van gezondheidsgegevens:

- Ondersteuning van de HDA door trusted data holders of betrouwbare houders van gezondheidsgegevens: grotere federale en regionale instellingen met ervaring zullen kunnen aangesteld worden als trusted data holders zodat we kunnen verder bouwen op hun kennis en ervaring en hun onafhankelijkheid maximaliseren. Dit betekent dat de taakbelasting op de HDA kan gereduceerd worden.
- Er was in 2025 intense samenwerking met de ziekenhuisdatanetwerken en de eerste gesprekken werden gevoerd rond de aanstelling van de ziekenhuisdatanetwerken als health data intermediation entities of bemiddelingsentiteiten.

De politieke beslissingen werden voor deze strategieën werden voorbereiden en zullen op het interministerieel niveau worden uitgewerkt in 2026.

Verder werden de voorbereidingen grotendeels ondersteund door **deelname aan verschillende Europese projecten**:

Tehdas2 Joint Action: De H.D.A. leverde een actieve bijdrage aan de voorbereidingen voor de uitvoeringshandelingen betreffende secundair gebruik van data



- Datacategorieën waarop de EHDS van toepassing zal zijn
- Vergoedings- en sanctiebeleid
- Opt-out
- Toevallige vondsten
- Technische aanbevelingen voor de data catalogus, de metadata, het systeem voor gegevensaanvragen, de beveiligde analyseomgeving en de verbinding met de centrale catalogus

HeDERA: samen met Sciensano en FOD VVVL ondersteunde dit project de verdere uitbouw van de HDA als Health Data Access Body nl verder zetten implementatie EHDS

- Health Data Enabled
for Re-use Across
Belgium

 - Specifieke definitie van de technische richtlijnen van de beveiligde analyseomgeving, met toepassingen in België
 - Cross border gateway and eDelivery connection
 - Stakeholder management

SHAIPED ondersteunt de HDA door AI trajecten op te zetten voor de ontwikkeling, het testen en de inzet van medische hulpmiddelen.



Door de samenwerking tussen de HDAB's te optimaliseren, maakt het gebruik van de EHDS-verordening en de AI-wet om de resultaten voor patiënten te verbeteren, de time-to-market voor medische

AI-hulpmiddelen te verkorten en het leiderschap van de EU op het gebied van digitale innovatie in de gezondheidszorg te versterken.



Het implementatieprogramma op Belgisch niveau, samen met de ondersteuning van de Europese projecten, levert de HDA een ontwikkelingsindex op van **43%** gebaseerd op de

voortgang op de verschillende ontwikkelingsaspecten.

Daarmee positioneert België zich zeer sterk boven het Europese gemiddelde (**index van 9%**) in de voorbereiding voor de implementatie van secondary use in Europa.

Member State

Belgium

Leadership and governance

HDAB formal designation

Governance model [MS]

Interoperability with data spaces [MS]

Organisational safeguards [HDA]

Strategy and investment

Strategic HDAB implementation plan [MS]

Budget allocation [MS]

Internal strategic implementation plan [HDAB]

Internal budget management plan [HDAB]

Fee management structure [HDAB]

Services and applications

Support for relevant stakeholders

Trainings for EHDS awareness

Populated nHDC

Requests and applications processing

SPEs as a service

Opt-out management

Standards and interoperability

HealtDCAT-AP compliance

Common Data Access Application form

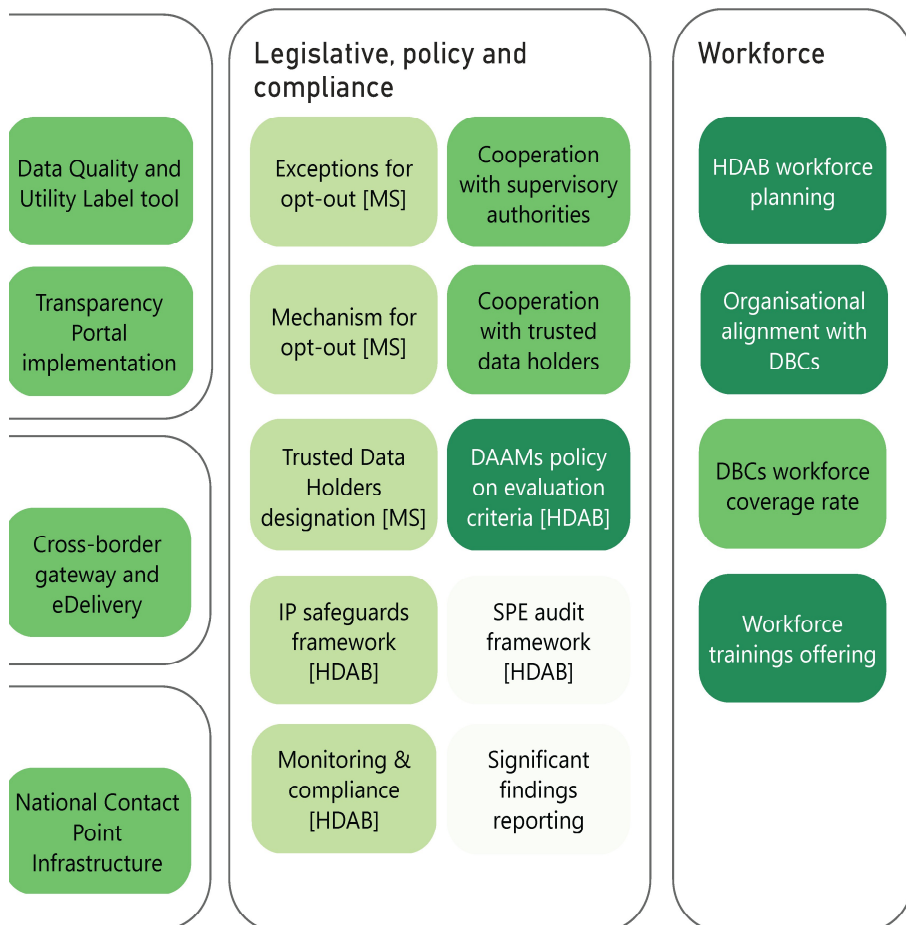
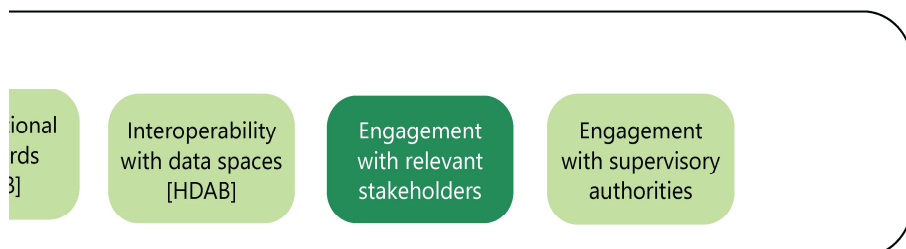
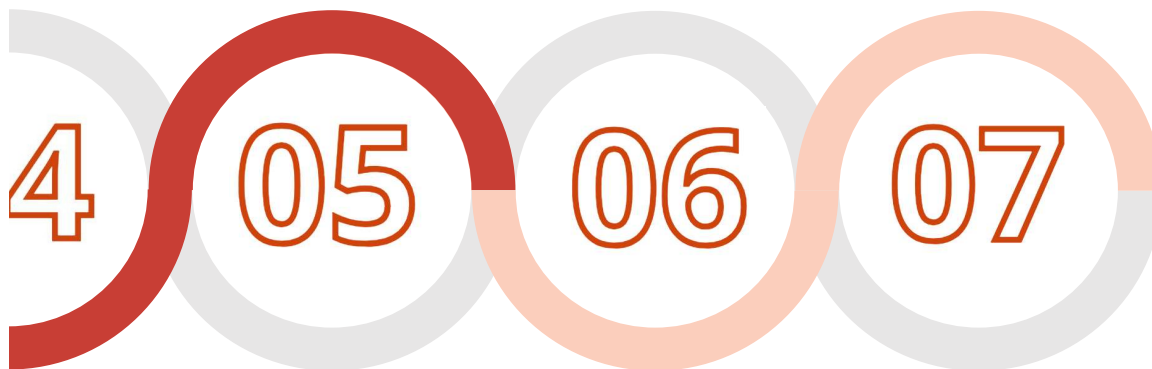
Common Health Data Request form

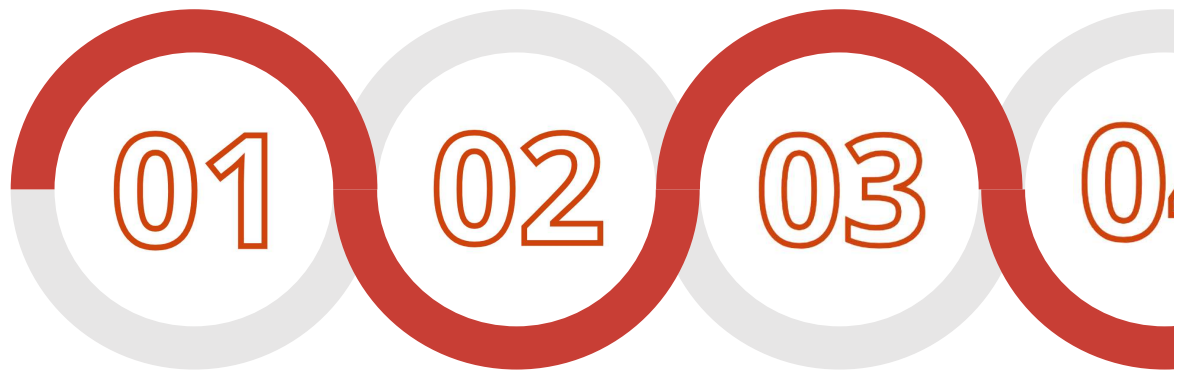
Infrastructure

Functional nHDC

DAAMs Infrastructure

Data preparation environment for HDABs





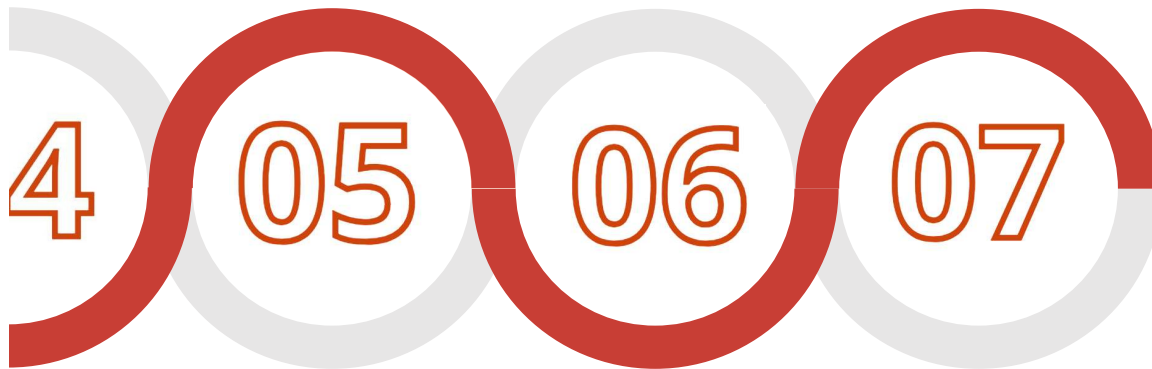
6. Policy

In 2025 zette de HDA haar rol als centrale motor van het Belgische gezondheidsdata-ecosysteem krachtig voort. Het agentschap nam een duidelijk proactieve positie in door actief in dialoog te gaan met academische instellingen, federale overheden en andere partners binnen het datalandschap. Dat gebeurde onder meer via de brede hervorming van het registerbeleid, waarbij de HDA een belangrijke rol speelde in de voorbereiding en toelichting van de nieuwe visie die in april 2025 werd voorgesteld. Deze visie hield rekening met diverse lopende initiatieven en met de vereisten van de European Health Data Space, waardoor de HDA zich positioneerde als aanspreekpunt voor organisaties die met gezondheidsdata werken.

Daarnaast werkte de HDA haar communicatie- en opleidingsaanbod verder uit. De Health Data Academy groeide in 2025 uit tot een volwaardig leerplatform dat stakeholders ondersteunt in het begrijpen van het gezondheidsdata-ecosysteem. De HDA zette in op transparante communicatie over het hergebruik van gezondheidsgegevens en op het creëren van vertrouwen, onder meer via publieke evenementen, webinars en de website. Dit communicatiefundament droeg bij aan een betere aansluiting tussen de noden uit het veld en de ondersteuning die de HDA biedt.

In haar rol als facilitator van onderzoek nam de HDA een actieve positie in door onderzoekers, overheden en andere datagebruikers te ondersteunen bij de toegang tot kwalitatieve gezondheidsdata. Door haar bemiddelende rol tussen gegevenshouders en -gebruikers zorgde het agentschap ervoor dat wetenschappelijke studies toegang kregen tot betrouwbare datasets, in overeenstemming met wettelijke en technische vereisten. De integratie van Healthdata.be in de HDA, zal die rol verder versterken. Door expertise en infrastructuur te bundelen, beoogd men in de komende jaren een coherenter en efficiënter databeleid, wat rechtstreeks zal bijdragen aan de ondersteuning van onderzoek.

Hoewel de HDA in 2025 zelf geen uitgebreide lijst van eigen onderzoeksrapporten publiceerde, speelde het agentschap wel een sleutelrol in de beschikbaarheid en kwaliteit van de data die gebruikt worden in gezondheidsrapporten op nationaal niveau. Deze rapporten omvatten informatie over onder meer mortaliteit, ziektelast en gezondheidsdeterminanten en worden gevoed door data van federale instellingen die in nauwe samenwerking staan met de HDA. Daarmee droeg de HDA indirect bij aan belangrijke nationale publicaties die de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking inzichtelijk maken.



7. Management

In 2025 zette de HDA belangrijke stappen in haar verdere uitbouw tot een autonoom en efficiënt opererend agentschap. Door de systematische versterking van haar interne processen, bestuur en communicatie groeide de organisatie uit tot een professioneel beheerde instelling binnen het Belgische gezondheidsdata-ecosysteem.

Gedurende het jaar werden de vergaderingen van het beheerscomité, het gebruikerscomité en de verschillende werkgroepen op regelmatige en gestructureerde wijze georganiseerd. Deze werkmethode zorgde voor een stabiele besluitvorming en een transparante opvolging van de werking. De voortgang van de strategische doelstellingen werd bovendien nauwgezet opgevolgd via een centraal dashboard, dat regelmatig werd bijgewerkt en fungeerde als een essentieel instrument voor datagedreven sturing. Alle wettelijke documenten, waaronder de begroting, het personeelsplan, beleidsbeslissingen en het activiteitenverslag, werden tijdig en volledig aangeleverd, wat de maturiteit van de administratieve werking verder onderstreepte.

Binnen het financieel beheer volgde de HDA nauwgezet de federale begrotingscyclus, inclusief het opstellen van een gedetailleerde retroplanning en tijdige rapportering aan het beheerscomité. Daarnaast werkte de organisatie een overzichtelijke staat van uitgaven en ontvangsten uit en werd een eerste versie van een monitoringtool ontwikkeld om de uitgaven nauwkeuriger en efficiënter te kunnen opvolgen. Deze inspanningen droegen bij aan een transparanter en professioneler financieel beheer.

Communicatie vormde een cruciaal bouwblok in de verdere professionalisering van de HDA. In 2025 werd gewerkt aan een communicatiestrategie die de taken, doelstellingen en meerwaarde van de HDA helder positioneert ten aanzien van beleidsmakers, dataleveranciers, onderzoekers en andere doelgroepen. Parallel werd een interne communicatiestrategie uitgewerkt, zowel gericht op geconnecteerde organisaties als op de eigen medewerkers, om samenwerking, transparantie en kennisdeling te bevorderen. Bovendien namen medewerkers van de HDA actief deel aan events, symposia en congressen, wat de zichtbaarheid en reputatie van het agentschap binnen het bredere ecosysteem verder versterkte.

Ten slotte werd het management plan aangepast naar de nieuwe doelstellingen voor 2026. Voor het eerst gebeurde dit aan de hand van een HDA Strategy Day, waarbij alle werknemers betrokken werden om ook hun input en visie voor 2026 te capteren. Hiernaast werd dit management plan verder uitgebreid tot een bruikbaar instrument dat het agentschap in staat stelt om haar voortgang en doelen efficiënt op te volgen.

Met deze realisaties bevestigde de HDA haar ontwikkeling tot een zelfstandige, efficiënt functionerende en professioneel beheerde organisatie, klaar om haar rol als spil in het gezondheidsdata-landschap verder te versterken in de komende jaren.





HDA